Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria

Rua Alameda Buenos Aires, 201 - Bairro: Nossa Senhora das Dores - CEP: 97050545 - Fone: (55) 3222-8888 - Email: frsantmari1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5004897-06.2024.8.21.0027/RS

AUTOR: TEREZA HELENA LEMES PEREIRA

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos e analisados os autos.

TEREZA HELENA LEMES PEREIRA**,** já qualificada, ajuizou ***Ação órdinária com pedido de tutela de urgência*** em face do **INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL - IPÊ-SAÚDE**, também qualificado, relatou ser portadora de Mieloma Múltiplo (Cadeia Leve Lambda – ISS IIA) [CID 10 C 90.0]. Mencionou que, inicialmente, realizou quimioterapia com esquema VRD para o tratamento de sua patologia, mas não obteve êxito. Informou ter sido prescrito novo tratamento com a utilização dos fármacos isatuximibe 500mg (14 frascos) e isatuximabe 100mg (28 frascos), com aplicação no primeiro ciclo de 33 mg iv nos dias d1 e d2, 116mg no d8 e d15 e do segundo ao sexto ciclo aplicar 116mg iv d1, d8 e d15; carfilzomibe 60mg (36 frascos), com aplicação no primeiro ciclo de 33mg iv nos dias d1 e d2, 116mg no d8 e d 15 e do segundo ao sexto ciclos aplicar 116mg iv d1, d8 e d15 – ciclos a cada 26 dia – mino 6 ciclos. Aduziu ter solicitado os medicamentos ao plano de saúde réu, mas foi indeferido sob a justificativa de que não está previsto nas atuais recomendações técnicas em oncologia do IPE Saúde. Afirmou o alto custo da medicação e a impossibilidade em adquiri-lá. Dissertou sobre o direito aplicável ao caso concreto. Por tais motivos, ajuízou a presente ação e, em sede de tutela provisória de urgência, pugna pelo fornecimento dos fámarcos postulados. Anexou documentos (evento 1, INIC1).

Recebida a inicial e deferida a gratuidade judiciária (evento 5, DESPADEC1).

Concedida a tutela de urgência (evento 15, DESPADEC1).

Citado, o **Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul - IPÊ-SAÚDE** apresentou contestação (evento 25, CONT1). Argumentou que os medicamentos postulados não estão previstos no Protocolo Oncológico adotado pelo IPE-Saúde para o tratamento da enfermidade apresentada. Referiu que é uma Autarquia estadual que tem sua cobertura definida pela Lei Complementar n° 15.145/2018 e pela Constituição Federal. Defendeu que diferentemente dos Planos de Saúde privados que possuem contratos com seus beneficiários e necessitam de cláusula contratual expressa para a negativa de cobertura, o IPE-Saúde é instituído por Lei e administrado por uma Autarquia estadual, o que determina a observação integral dos princípios aplicáveis à Administração Pública. Discorreu sobre a sustentabilidade do fundo de assistência à saúde-FAS. Afirmou a necessidade coparticipação do usuário. Requereu a improcedência do pedido.

Apresentada réplica (evento 29, RÉPLICA1).

O Ministério Público, em promoção, opinou pela procedência da ação (evento 41, PROMOÇÃO1).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a fundamentar.

Inicialmente, tratando-se de questão unicamente de direito, desnecessária a produção de provas em audiência, sendo possível o julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A parte autora afirma na inicial que, consoante relatório lavrado pela Dra. Juliana Chiodelli Salvador, foi diagnosticada com Mieloma Múltiplo (Cadeia Leve Lambda – ISS IIA), CID10 C 90.0, tendo apresentado refratriedade a primeira linha de tratamento, o que indica que o novo tratamento prescrito com a medicação Isatuximibe 500mg, Isatuximabe 100mg e Carfilzomibe 60mg, deve ser iniciado o mais brevemente possível, uma vez que a doença diagnosticada na Autora se caracteriza pela sua rápida evolução com risco de progressão e morte, caso o tratamento não seja iniciado imediatamente.

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul - IPÊ-SAÚDE arguiu que o fornecimento dos medicamentos não estão previstos nas atuais recomendações técnicas de oncologia do Ipê-Saúde.

Inicialmente, cabe salientar que o artigo 4º da Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre o IPÊ-Saúde, refere que integram o plano de saúde atendimento médico, hospitalar, atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, assim como ações de prevenção da doença e promoção à saúde: *(...) Artigo 4º- O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema **IPE** Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos*

procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor. (...)

Todavia, o parágrafo único do artigo 4º da citada Lei Complementar restringe o fornecimento de tratamentos, exames, procedimentos, insumos e materiais aos que estejam previsto nas tabelas do Instituto.

Insta frisar que, em que pese exista a previsão de exclusão na legislação de regência, somente justifica-se a sua incidência quando não comprovada a necessidade do fornecimento dos tratamentos, exames, procedimentos, insumos e materiais para o tratamento da patologia de que está acometido o segurado, conforme entendimento sedimentado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

> *"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ- SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER JAKAVI® (RUXOLITINIBE). PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC.* ***A circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento do IPERGS não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. Conforme dispõe o art. 4º da Lei Complementar 15.145/08, integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários.*** *Em que pese as disposições do parágrafo primeiro do artigo supramencionado, tem-se que a ausência de previsão no Protocolo Oncológico não deve servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado, notadamente porque as Recomendações são de 2010, logo desarrazoado negar acesso do segurado a tratamento médico quando evidente a ausência de atualização do Protocolo e suas Recomendações em Oncologia. Hipótese dos autos em que se encontram presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela requerida, uma vez que restou comprovada a necessidade e a urgência do medicamento solicitado, através de laudo médico especializado, razão pela qual imperiosa a manutenção da tutela provisória de urgência concedida na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70079951091, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 27/02/2019)" [grifo nosso]*
>
> *"APELAÇÃO CÍVEL. IPÊ-SAÚDE. LINFOMA NÃO-HODGKIN. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IBRUTINIBE. NEGATIVA DO IPERGS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.* ***I. A Lei nº 12.134/2004, que reestruturou o IPERGS, dispõe que o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, seus dependentes e pensionistas, engloba um conjunto de ações visando à prevenção de doenças, à promoção, educação e assistência à saúde de seus usuários (arts. 1º e 2º). II. Em que pese a edição da Lei Complementar nº 15.145/2018, que altera a Lei Complementar nº 12.066/2004, disciplinando que descabe a imposição ao IPERGS de medicamentos não previstos em seus regramentos, entendo que a falta de previsão nos protocolos ou listas da autarquia previdenciária e o alto custo do medicamento não devem servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento postulado, visto que demonstrada a necessidade do uso do fármaco, bem como a condição de segurado da autarquia.*** *III. Honorários advocatícios reduzidos. Apelo parcialmente provido. (Apelação Cível Nº 70080627953, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 27/03/2019)"*

Ademais, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento de que não cabe ao plano de saúde selecionar o tratamento que será dispensado ao segurado para a patologia coberta pelo plano, como ilustram as seguintes ementas de julgados proferidos pelo Tribunal da Cidadania:

> *"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.* ***3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo.*** *4. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no recurso especial desprovido. (AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019)" [grifo nosso]*
>
> *"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.* ***3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo.*** *4. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no recurso especial desprovido. (AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019)" [grifo nosso]*

Dessa forma, extrai-se dever do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul - IPÊ-SAÚDE em fornecer o tratamento postulado pela parte autora, mesmo que este não esteja coberto pelo plano ou que não esteja previsto no Protocolo do Instituto, desde que comprovada a sua necessidade.

Necessário consignar que a postulante comprova ser beneficiária do plano de saúde oferecido pela parte demandada, conforme se visualiza no evento 1, OUT7. Dessa forma, friso que o regime de responsabilidade da parte ré na situação posta é mais específico e decorre do vínculo contratual oriundo do próprio plano de saúde.

Ainda, destaco o laudo médico confecionado pela médica Juliana Chiodelli Salvador (evento 1, OUT13), ressaltou a necessidade de utilização dos fármacos, pois a realização de quimioterapia com esquema VRD não foi eficiente para o tratamento da doença, conforme transcrevo trecho do laudo: *" (...) A paciente TEREZA HELENA LEMES PEREIRA, 65 anos, é portador de Mieloma Múltiplo (Cadeia Leve Lambda), CID 10 C 90.0, com diagnóstico em setembro/2023. A paciente já realizou quimioterapia com esquema VRD (Lenalidomida, Bortezomibe e Dexametasona) associado a Àcido sem resposta da doença, caracterizando doença refratária a primeira linha de tratamento. Tem indicação de novo tratamento quimioterápico com protocolo ainda não utilizado para melhor resposta da doença e transplante de médula óssea autóloga. (...) 2. Qual é o medicamento que o paciente necessita? Qual a posologia indicada? Os medicamentos solicitados são: 1. ISATUXIMIBE 500MG (...) 2. ISATUXIMIBE 100MG (...) 3. CARFILZOMIBE 60MG. (...)".*

O laudo médico restou corroborados por outro laudo médico (evento 1, LAUDO9) e por exame médico (evento 1, EXMMED12).

Portanto, diante do laudo médico juntado pela parte autora aliado aos exames e às informações mencionadas, resta evidente a necessidade da autora em realizar o tratamento farmacológico pleiteado, para tratamento da patologia que lhe acomete.

Consigno que mesmo demonstrada a necessidade do tratamento pela parte autora, restou indeferido em sede administrativa o fornecimento dos medicamentos postulados na exordial (evento 1, OUT8).

No entanto, como já exposto, embora não previstos *"nas recomendações técnicas do IPÊ-RS"*, tal circunstância não é suficiente para elidir a responsabilidade da Autarquia ré em fornecer o tratamento adequado para a patologia da demandante.

Quanto à tese defensiva de necessidade de coparticipação financeira do usuário para o custeio do plano de assistência médica ventilada em sede de contestação consoante redação do §1º, artigo 2º, da Lei Complementar n° 15.145/2018, tenho que não assiste razão ao instituto réu.

Isso porque o artigo 30 da Lei Complementar n° 15.145/2018 prevê a coparticipação dos usuários do sistema IPE-Saúde tão somente em relação a despesas com consultas, exames complementares, serviços ou procedimentos fora do ambiente hospitalar, o que não se enquadra no caso em exame, **que versa sobre pedido de medicamento.**

Dessa forma, verificando ser o caso de internação hospitalar, tenho por incidente a exceção prevista no § único do art. 30 da Lei Complementar n. 15.145/2018:

Nesse sentido:

> *"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER KYPROLIS (CARFILZOMIBE) E DALINVI (DARATUMUMABE). PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Fornecimento de medicametnos não contremplados nas listas/protocolos da autarquia. A circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento do IPE-Saúde não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. Conforme dispõe o art. 4º da Lei Complementar 15.145/08, integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários. Em que pese as disposições do parágrafo primeiro do artigo supramencionado, tem-se que a ausência de previsão no Protocolo Oncológico não deve servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado. Hipótese dos autos em que se encontram presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela requerida, uma vez que restou comprovada a necessidade e a urgência dos medicamentos solicitados, através de laudo médico especializado, razão pela qual imperiosa a manutenção da decisão recorrida. Coparticipação do usuário.* ***A coparticipação do usuário é cabível quando da realização de consultas, exames complementares, serviços ou procedimentos. No caso dos autos, a parte autora postula o fornecimento de medicamentos, razão pela qual é indevida a coparticipação financeira do segurado, nos termos do art. 30 da Lei Complementar nº 15.145/2018****. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51015966320228217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 27-07-2022)"[grifei]*

Em consequência, deve ser afastada a tese defensiva de copartipação da autora no custeio dos medicamentos pleiteados, impondo-se a procedência do pedido.

Dispositivo

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por TEREZA HELENA LEMES PEREIRA em face do **INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL-IPÊ-SAÚDE** para determinar que o réu **forneça os medicamentos Isatuximibe 500mg (14 frascos) e Isatuximabe 100mg (28 frascos),** conforme laudo médico, sob pena de bloqueio de valores, nos termos do artigo 497, inciso I, do Código de Processo Civil.

Confirmo a tutela de urgência deferida no evento 15, DESPADEC1.

Isento o IPÊ-SAUDE quanto ao pagamento da taxa única, nos termos do art. 5º da Lei Estadual nº 14.634/2014, bem como das despesas de condução de Oficial de Justiça, exceto a título de desembolso. Deverá adimplir apenas as demais despesas processuais.

Outrossim, condeno o IPÊ-SAUDE ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais fixo em R$ 600,00, nos termos do §8° do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015.

Havendo apelação, considerando as novas disposições do Novo Código de Processo Civil (art. 1.010), que determina a remessa do recurso independentemente de juízo de admissibilidade no primeiro grau, deverá o Cartório intimar a parte recorrida para oferecer contrarrazões e dar vista ao Ministério Público para parecer, se for o caso, e, na sequência, remeter os autos à instância superior.

Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, deve ser submetida ao reexame necessário, consoante entendimento cristalizado na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, com ou sem recurso voluntário, remetam-se os autos ao Colendo Tribunal de Justiça para reexame.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Documento assinado eletronicamente por **DIEGO TEIXEIRA DELABARY, Juiz de Direito**, em 14/02/2025, às 14:23:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10074573325v4** e o código CRC **f2444adb**.